

喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用

李建秀

(淄博市妇幼保健院, 山东 淄博 255000)

【摘要】目的 探讨喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用。**方法** 根据笔者临床经验结合查阅知网近年来有关喹诺酮类药物的文献,进行归纳总结。**结果** 喹诺酮类药物不良反应主要有胃肠道反应、对中枢神经系统的不良反应、皮肤过敏反应、对心血管系统的不良反应、肝毒性以及肌腱、软骨等。与氨基糖苷类药物、 β -内酰胺类药物、利福平及其它抗菌药等均可产生药物相互作用。**结论** 喹诺酮类药物不良反应广泛,但严重不良反应较少;其与多种药物均可产生相互作用,临床应谨慎使用,严密观察患者使用后可能产生的不良反应。

【关键词】 喹诺酮类; 不良反应; 药物相互作用

【中图分类号】 R969

【文献标识码】 A

【文章编号】 ISSN.2095-8242.2019.26.177.02

DOI:10.16281/j.cnki.jocml.2019.26.128

喹诺酮类药物是一类含有4-喹诺酮母核的人工合成抗菌药,具有抗菌谱广、抗菌力强、口服吸收好、组织浓度高等优点,传统意义上认为其不良反应少、药物相互作用少,但随着临床长期的广泛使用,其不良反应与药物相互作用逐渐显现。本研究通过根据笔者临床使用喹诺酮类药物所观察到的情况,结合查阅知网上所刊载的近年来其他学者研究的有关喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用的文献,进行综述。

1 不良反应

1.1 胃肠道反应

胃肠道反应几乎是所有口服药物共同具有的不良反应,喹诺酮类药物所常见胃肠道反应主要是恶心、呕吐、腹痛、腹泻,有患者表现为胃胀、腹胀、厌食等,较少患者表现为吞咽困难、流涎、便秘等。静脉给药较少发生,常发生于口服,停药后症状逐渐消失。

1.2 中枢神经系统反应

喹诺酮类药物在中枢神经系统中的不良反应大多数患者表现为头痛、失眠,少数患者会发生抽搐。陈晓玲等^[1]

曾报道有患者以咽痛发热就诊,门诊给予氟罗沙星静脉给药,半小时后患者发生舌颤、手足麻木,随后出现上肢剧烈抽搐。有研究表明喹诺酮类药物的结构中具有氟原子,使药物具有脂溶性高的特性,易通过血脑屏障而引起中枢神经系统反应。另有学者研究其含有的哌嗪环使药物结构与GABA受体拮抗剂相类似,从而提高中枢兴奋性。因此,癫痫病患者应谨慎或避免使用。

1.3 心血管系统反应

截止到1999年,有7例患者在服用格帕沙星后发生心脏猝死,现格帕沙星临床使用已较少。张燕等^[2]报道1例患者服用司帕沙星后发生尖端扭转型室速、室颤。以上报道说明喹诺酮类药物可能具有一定的导致心脏不良反应的作用,对于心功能不全的患者,应尽量不应用司帕沙星,必须应用时应注意用量。

1.4 软骨毒性

动物实验研究表明喹诺酮类药物会影响新生活幼小动物的骨骼增长板。儿童长期使用喹诺酮类药物,则可能导致生长发育障碍。喹诺酮类药物对软骨的毒性一般为一次性并且可逆,停药后可缓解,但成人长期服用导致的软骨

3 讨论

糖尿病肾病作为一种常见的合并症,其会随着时间的延长而恶化,多表现为持续性蛋白尿、肾小球供血减少等现象^[3]。同时,糖尿病会使得患者的血糖含量异常,很容易诱发其他疾病。因此,在临床工作中,必须要对这种疾病采取积极的治疗措施。福辛普利作为常见的糖尿病肾病用药,是一种血管紧张素转化酶抑制剂,其能够促使药物在病灶发生转变,促进肾脏组织的压力改善,进而扩张动脉,改善肾小球的过滤功能,降低蛋白尿的排泄。前列地尔是一种脂微球载体剂,其能够靶向作用于肾血管,使之扩张,血流量有所改善,进而达到肾小球血液循环状况优化的目的。这两种药物联合作用时,能够最大程度地改善

患者的肾功能。

综上所述,前列地尔联合福辛普利治疗糖尿病肾病患者的临床效果显著,能够有效地改善患者的肾功能,且安全性高,值得推广。

参考文献

- [1] 邢明旭.前列地尔联合福辛普利治疗对糖尿病肾病患者肾功能的影响[J].北方药学,2018,15(11):73-74.
- [2] 王 强,周晓花.前列地尔联合福辛普利治疗糖尿病肾病蛋白尿的临床效果观察[J].云南医药,2018,39(02):147-148.
- [3] 谢伟群,董建新,戴冬琴.前列地尔联合福辛普利治疗糖尿病肾病蛋白尿的临床疗效及安全性评价[J].北方药学,2018,15(02):170-171.

本文编辑: 吴 卫

萎缩较难恢复^[3]。

1.5 皮肤过敏反应

皮肤过敏反应多表现为荨麻疹、红斑等，严重者可发生过敏性休克，但较为少见。部分患者会发生下肢凹陷性水肿，有少数男性患者会发生包皮水肿。有报道2例患者服用喹诺酮类药物后发生强皮肤反应。

1.6 光反应毒性

有患者服用喹诺酮类药物后，受光照后皮肤出现红斑，并可发展为大疱疹。研究表现8位氟取代的药物光毒性最强，8位甲氧基取代的药物光毒性最弱。洛美沙星、司帕沙星、氟罗沙星等药物均具有较强的光毒性。对于皮肤敏感、有过敏史的患者应嘱其若发生疑似光毒性的反应尽快就医。

1.7 肝、肾毒性毒性

喹诺酮类药物多数以原型经肾排出，少量药物在肝脏代谢或随粪便排出，故肝、肾毒性较少见。但也有患者服用喹诺酮类药物后发生严重后果，有报道有患者使用氧氟沙星后出现少尿。肝毒性大多患者表现为一过性的肝功能生化指标异常，停药处理后很快恢复。

1.8 其他

有报道称乳酸环丙沙星会导致肠道菌群紊乱，表现为便秘、腹泻；氟哌酸会引发口腔溃疡等。

2 药物相互作用

2.1 其它抗菌药

与氨基糖苷类合用可产生协同作用，对于大肠杆菌引发的感染效果倍增。与β-内酰胺类药物合用可利用其破坏细

胞壁的作用，发挥更强杀菌作用^[4]。与磺胺嘧啶合用，可增强杀灭抗绿脓杆菌、金葡萄球菌的作用。

与利福平合用可导致喹诺酮类药物抗菌作用降低。与氯霉素、红霉素合用可使不良反应加重。

2.2 其它药物

与茶碱、咖啡因、华法林等合用可抑制合用药物的代谢。与非甾体类抗炎药合用对癫痫患者可增大诱发癫痫的几率。与H₂受体拮抗剂合用可导致喹诺酮类药物毒性增强^[5]。与多价金属阳离子合用可使抗菌作用消失。

喹诺酮类药物可诱发包括胃肠道反应在内的多种不良反应，但严重不良反应较少见。临床使用应熟悉其禁忌和应谨慎使用的人群，与其它药物合用时需明确是否有相互作用。

参考文献

- [1] 陈晓玲,陈晓东.氟罗沙星引起神经系统不良反应[J].药物不良反应杂志,2015,5(1):41.
- [2] 张燕,伍卫,王景峰,等.司帕沙星致尖端扭转型室速,心室颤动1例[J].中华心血管杂志,2016,29(7):583.
- [3] 曲芬,姜素椿.喹诺酮类药物的软骨毒性[J].中国临床药物杂志,2015,7(6):316.
- [4] 曹丽荣,冯建文,王军.简述喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用[J].中华医药杂志,2015,5(1):465.
- [5] 王丽,朱珊,刘彩虹.喹诺酮类药物不良反应108例分析及合理应用[J].实用诊断与治疗杂志,2016,20(1):44.

本文编辑：李豆

(上接175页)

根据北京市医疗机构处方专项点评指南中血液制品处方点评指南，人血白蛋白注射液对于以下人群禁用：1.急性肺水肿患者；2.对白蛋白有严重过敏者；3.高血压患者，急性心脏病者、正常血容量及高血容量的心力衰竭患者；4.严重贫血患者；5.肾功能不全者。一病例诊断为“急性左心衰；冠状动脉粥样硬化性心脏病；陈旧性心肌梗死”，ALB浓度39.8 g/L。该患者为急性左心衰患者，人血白蛋白的使用会提高血浆胶体渗透压，液体从组织间隙进入血管，从而增加有效循环血容量^[5]。对于急性左心衰这类高血容量的心力衰竭患者，人血白蛋白的使用会增加其心脏负荷，因而该类人群为人血白蛋白使用的禁忌人群。且本例患者无低蛋白血症，使用人血白蛋白注射液不适宜。因而在人血白蛋白的临床使用中还需关注其禁忌人群，保证安全合理用药。

4 小结

综合2017年人血白蛋白注射液点评情况，我院仍存在人血白蛋白不合理使用情况。医师应加强学习相关知识，

严格把握用药指征，对于药师而言，也应该加强学习，提高技能，并加强与临床的沟通，共同制定我院人血白蛋白的使用规范，完善评估标准，促进临床合理安全用药。

参考文献

- [1] 中华人民共和国卫生部.医院处方点评管理规范（试行）[S].卫医管发[2010].
- [2] 中华人民共和国卫生部.北京市医疗机构处方点评指南[S].卫医管发[2012].
- [3] The University Hospital Consortium.Adapted from UHCGuidelines for the Use of Albumin, Nonprotein Colloid,and Crystalloid Solutions[S]. 2000-05-01.
- [4] 左橙子,原海燕,徐萍,等.某三甲医院老年患者人血白蛋白使用评价及分析[J].中国药物应用与监测,2015,12(1):36-39.
- [5] 张婷,吴慧,卞海林,等.人血白蛋白临床应用医嘱点评标准于模式探讨[J].药学与临床研究,2016,24(1):69-72.

本文编辑：吴卫